

CONTRASTE — HIDRATAR O DE RISCO, NÃO ATRASAR O EXAME

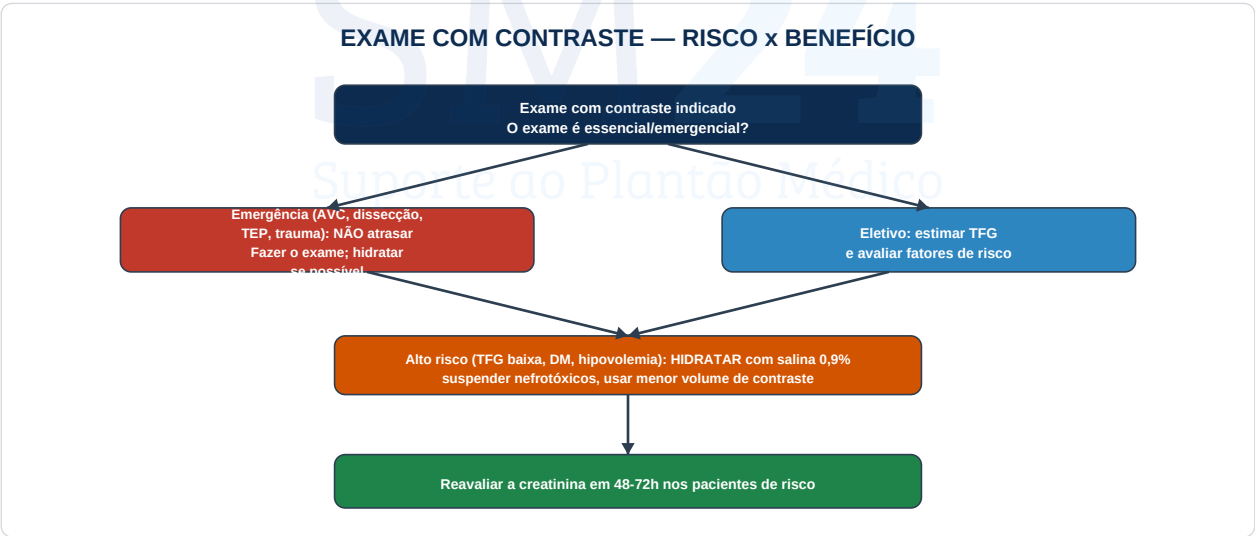
CONCEITO E DEFINIÇÃO

Aspecto	Detalhe
Definição	Aumento da creatinina $\geq 0,3$ mg/dL (ou $\geq 50\%$) em 48-72h após o contraste, sem outra causa
Terminologia atual	Distinguir 'associada' (temporal) de 'induzida' (causal) pelo contraste — o risco real é menor do que se pensava
Via	Risco maior com contraste intra-arterial e em grande volume
Curso	Geralmente transitória, com pico em 3-5 dias e recuperação em 1-2 semanas
Tipo de contraste	Iodado (TC, angiografia). Gadolínio (RM) tem outro risco (fibrose sistêmica nefrogênica na DRC avançada)
Mensagem-chave	NUNCA atrasar um exame com contraste essencial (ex.: AVC, dissecção, TEP) por medo da nefropatia

FATORES DE RISCO

Categoria	Fatores
Renal (principal)	DRC prévia (TFG $< 30-45$), lesão renal aguda em curso
Comorbidades	Diabetes (sobretudo com nefropatia), IC, idade avançada
Hemodinâmico	Hipovolemia, hipotensão, uso de drogas nefrotóxicas (AINE, aminoglicosídeo)
Relacionado ao exame	Grande volume de contraste, via intra-arterial, exames repetidos em curto intervalo
Baixo risco	Função renal normal e paciente euvolêmico — risco muito baixo, sem necessidade de profilaxia agressiva

DECISÃO ANTES DO CONTRASTE



PREVENÇÃO — O QUE FUNCIONA E O QUE NÃO

HIDRATAÇÃO É A MEDIDA CENTRAL

- Hidratação com salina 0,9% é a principal e mais comprovada medida de prevenção no paciente de risco
- Esquema comum: salina 0,9% 1 mL/kg/h por 6-12h antes e após (ou bolus peri-procedimento em emergências)
- Usar o MENOR volume de contraste possível e evitar exames repetidos em curto intervalo
- Suspende nefrotóxicos (AINE, aminoglicosídeo) e evitar hipovolemia/hipotensão
- N-acetilcisteína e bicarbonato de sódio: NÃO recomendados de rotina (sem benefício consistente)
- Metformina: não causa a nefropatia, mas suspender se houver lesão renal (risco de acidose lática); reavaliar a função renal antes de reintroduzir
- Diálise profilática para 'remover o contraste' NÃO é indicada

ARMADILHAS E CONTEXTO

Não Fazer

- Atrasar TC de crânio/angio-TC em emergência por causa da creatinina
- N-acetilcisteína ou bicarbonato de rotina (sem evidência sólida)
- Diálise apenas para retirar o contraste
- Restrição hídrica antes do exame
- Suspende uma medicação vital sem avaliar o contexto

Boas Práticas

- Identificar o paciente de risco (TFG baixa, DM, hipovolemia)
- Hidratar com salina 0,9% antes e depois quando possível
- Menor volume de contraste e contraste de baixa osmolaridade/isosmolar
- Suspende nefrotóxicos no período
- Reavaliar a creatinina em 48-72h nos pacientes de risco
- Documentar a relação risco-benefício na decisão

CONDUTA PRÁTICA

PONTOS-CHAVE

- ☐ Nunca atrasar um exame com contraste essencial/emergencial por medo da nefropatia
- ☐ Estimar a TFG e identificar os fatores de risco antes do exame eletivo
- ☐ Hidratação com salina 0,9% é a medida central de prevenção no paciente de risco
- ☐ Usar o menor volume de contraste e suspender nefrotóxicos
- ☐ Não usar N-acetilcisteína/bicarbonato de rotina nem diálise profilática
- ☐ Suspende metformina se houver lesão renal e reavaliar a creatinina em 48-72h

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com suspeita de AVC isquêmico em janela para trombólise precisa de neuroimagem com contraste, mas tem DRC. Qual a conduta?

- A) Adiar o exame até melhorar a função renal
- B) Realizar o exame (emergência tempo-dependente) sem atraso, hidratando quando possível
- C) Substituir por exame sem nenhuma utilidade diagnóstica
- D) Indicar diálise profilática antes do exame
- E) Administrar N-acetilcisteína e aguardar 12h

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a principal medida comprovada de prevenção da nefropatia induzida por contraste no paciente de risco?

- A) N-acetilcisteína oral
- B) Hidratação com salina 0,9%
- C) Bicarbonato de sódio IV
- D) Diálise profilática
- E) Restrição hídrica

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Sobre a metformina e o contraste iodado, qual afirmação é correta?

- A) A metformina causa diretamente a nefropatia por contraste
- B) A metformina não causa a nefropatia, mas deve ser suspensa se houver lesão renal (risco de acidose láctica), reavaliando a função renal antes de reintroduzir
- C) A metformina deve ser mantida mesmo na lesão renal aguda
- D) A metformina deve ser suspensa por 30 dias em todos os pacientes
- E) A metformina protege contra a nefropatia por contraste

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual conduta NÃO é recomendada de rotina para prevenção da nefropatia por contraste?

- A) Hidratação com salina 0,9%
- B) Uso do menor volume possível de contraste
- C) N-acetilcisteína e bicarbonato de sódio de rotina
- D) Suspensão de nefrotóxicos
- E) Reavaliação da creatinina em 48-72h

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual paciente tem o MAIOR risco de nefropatia induzida por contraste?

- A) Jovem com função renal normal e euvolêmico
- B) Paciente com DRC avançada, diabético e hipovolêmico
- C) Paciente hipertenso controlado sem outras comorbidades
- D) Gestante saudável
- E) Paciente com função renal normal em uso de IECA

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Em emergências tempo-dependentes (AVC em janela, dissecação, TEP), o exame com contraste NÃO deve ser atrasado por medo da nefropatia — o benefício diagnóstico supera amplamente o risco renal. Hidratar quando possível, sem postergar.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A hidratação com salina 0,9% é a medida central e mais comprovada de prevenção no paciente de risco. N-acetilcisteína, bicarbonato e diálise profilática não têm benefício consistente e não são recomendados de rotina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A metformina não causa a nefropatia por contraste. Porém, se houver lesão renal, deve ser suspensa pelo risco de acúmulo e acidose láctica, reavaliando-se a função renal antes da reintrodução.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

N-acetilcisteína e bicarbonato de sódio NÃO são recomendados de rotina (sem evidência de benefício consistente). As medidas eficazes são hidratação com salina, menor volume de contraste, suspensão de nefrotóxicos e reavaliação da creatinina.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O maior risco está no paciente com DRC avançada (TFG baixa), diabético e hipovolêmico — a combinação de comprometimento renal prévio, microangiopatia e baixa perfusão renal. Esses pacientes se beneficiam de hidratação e menor volume de contraste.

SM24
Suporte ao Plantão Médico